

SGLT2 억제제 신규 처방 주의사항

포시가(다파글리플로진) · 자디앙(엠파글리플로진) · 슈글렛(이프라글리플로진). 혈당과 함께 심부전·신장도 보호하는 약물이지만 안전 복용을 위해 아래 사항을 꼭 확인해 주세요.

👁 한눈에 보는 안전 복용 수칙

매일 수분 섭취
1.5~2

L / 일 (탈수 예방) · 심부전 등으로 물 제한을 받은 분은 의사가 정한 양

수술·시술 전 중단
3

일 전 (수술 전 3일 중단 규칙)

콩팥 기능
eGFR ≥ 30

사구체여과율 mL/min · 이 이상에서
혈당 효과 · 포시가는 25까지 시작

생식기 진균 감염 위험
3~5

배 ↑ (위생 관리 필수)

콩팥 기능 참고 — 콩팥·심장 보호 목적이면 더 낮은 수치(KDIGO 2024: 20 이상)에서도 의사가 시작할 수 있습니다.

🔗 SGLT2 억제제는 어떻게 작용하나요?



콩팥에서 당을 소변으로 내보냅니다

SGLT2(콩팥에서 당을 다시 흡수하는 단백질)를 차단해 **혈당을 소변으로 직접 배출**합니다. 저혈당 위험이 낮고, 심혈관·신장 동반 환자에게 우선 권고됩니다.

👉 기대 효과	정도
소변으로 당 배출	하루 50~80g · 200~320 kcal
당화혈색소(HbA1c)	약 0.6~0.9% ↓
체중 · 수축기혈압	체중 2~3kg ↓ · 수축기혈압 3~5 mmHg ↓
심부전 · 신장 보호	당뇨 없어도 심부전 입원 ↓ 30% · 신장기능 악화 ↓ 40%

📅 복용 중 일상 수칙

🛡 권장 행동	❌ 피해야 할 행동
매일 물 1.5~2L (심부전 등으로 물 제한을 받은 분은 의사가 정한 양) — 탈수·저혈압 예방의 핵심	임의로 중단·증량 금지 — '아픈 날 규칙' 해당 시간 예외
회음부 청결 유지 — 배뇨 후 마른 수건, 통기성 속옷	극단적 저탄수화물·키토 다이어트 금지 — 정상혈당 케톤산증 위험 ↑
정해진 시간에 매일 1회 복용 — 식사와 무관, 아침 권장	장시간 금식·과음 금지 — 케톤 생성 자극, 탈수 가중
인슐린·메트포민은 그대로 유지 — 임의로 함께 줄이지 않기	더운 날·운동 후 수분 부족 방치 금지 — 어지러움·실신 위험
정기 혈액검사(3~6개월) — 신기능·전해질·당화혈색소 확인	회음부 통증·홍반·가려움 무시 금지 — 즉시 진료 필요
약 이름·용량을 가족·다른 의료진과 공유 — 응급 시 즉시 안내	자가 판단으로 이노제·소염진통제(NSAIDs) 추가 복용 금지 — 신기능 악화 위험

⚠ 즉시 약 중단 + 응급실 방문이 필요한 경우

🚑 아픈 날 규칙 · 일시 중단 후 의료진 연락

- 발열·구토·설사로 식사 못 할 때 — 즉시 중단, 회복 후 재개
- 수술·전신마취·수면내시경 **3일 전** — 수술 전 3일 중단 규칙, 시술 후 재개
- 24시간 이상 단식·급성 입원 시** — 입원 의료진에 복용 알림

즉시 **119** 또는 응급실

- 정상혈당 케톤산증 — 오심·구토·복통·과호흡·과일향 입냄새 (혈당 정상이어도!)
- 푸르니에 괴저 — 회음부·생식기 심한 통증·붓기·홍반 + 발열 (생명 응급)
- 심한 탈수·기립성 저혈압 — 실신·8시간 이상 소변 거의 없음

함께 보기 — 설명 슬라이드 「당뇨 첫 외래 안내」 edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/diabetes-first-visit/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2025 ADA Standards of Care · 2023 KDA 당뇨병 진료지침 · KDIGO 2024 CKD Guideline · FDA Drug Safety Communication (Fournier's Gangrene, 2018)

본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/sglt2-precautions/

